

GENERAL EXAMINATION

الفحص العام

الأستاذ حسن نصر الله | Professor Hassan Nassrullah

1. OBJECTIVES AND CLINICAL APPROACH | الأهداف والمقاربة السريرية

Objectives (Bloom's Taxonomy)

الأهداف (بحسب تصنيف بلوم)

Remembering (التذكر)

- Recall steps in a clinical approach to diagnosis.
- List components of general and systemic examination.
- Identify six fixed general signs.

تذكر خطوات المقاربة السريرية للتشخيص.

سرد مكونات الفحص العام والفحص الجهازى.

تحديد العلامات العامة الثابتة الست.

Understanding (الفهم)

- Explain the importance of history and general examination.
- Describe features of pallor, jaundice and cyanosis.
- Differentiate between central and peripheral cyanosis.

شرح أهمية القصة والفحص العام.

وصف ملامح الشحوب واليرقان والزرقة.

التمييز بين الزرقة المركزية والمحيطية.

Applying (التطبيق)

- Demonstrate patient approach and hand hygiene.
- Measure vital signs and oxygen saturation.
- Perform inspection to recognize abnormalities.

إظهار طريقة الاقتراب من المريض ونظافة اليدين.

قياس العلامات الحيوية وإشباع الأكسجين.

إجراء المعاينة للتعرف على الشذوذات.

Analysing (التحليل)

- Distinguish between localized and generalized oedema.
- Analyse the patient environment and correlate it with health status.
- Compare different examination sequences.

التمييز بين الوذمة الموضعية والعامة.

تحليل بيئة المريض وربطها بالحالة الصحية.

مقارنة تسلسلات الفحص المختلفة.

Evaluating (التقييم)

- Judge the importance of general vs systemic exam.

الحكم على أهمية الفحص العام مقابل الجهازى.

- Prioritize investigations based on signs.

ترتيب أولويات الاستقصاءات بناءً على العلامات.

- Critically assess pathological causes of clinical signs.

تقييم الأسباب المرضية للعلامات السريرية بشكل نقدي.

Creating (الابتكار (الإنشاء))

- Plan a full general examination of a new patient.

تخطيط فحص عام كامل لمريض جديد.

- Develop a personal clinical checklist.

وضع قائمة تحقق سريرية شخصية.

- Design a case presentation linking signs with diagnosis.

تصميم عرض حالة يربط العلامات بالتشخيص.

Clinical Approach

المقاربة السريرية

Steps to be taken to reach a diagnosis:

الخطوات المتبعة للوصول إلى التشخيص:

- It involves taking a full history and doing a full physical examination, plus performing some investigations if needed.

تتضمن أخذ قصة كاملة وإجراء فحص سريري كامل مع إجراء بعض الاستقصاءات إذا لزم.

- Physical examination involves general and systemic examination.

يتضمن الفحص السريري الفحص العام والجهازي.

- General examination is far more important than systemic examination.

الفحص العام أهم بكثير من الفحص الجهازي.

Components of General Examination (Approach)

مكونات الفحص العام (الاقتراب)

- Greet the patient and relative.

حيّ المريض ومرافقه.

- Introduce yourself.

عرّف بنفسك.

- Explain to the patient what you are going to do.

اشرح للمريض ما ستفعله.

- Clean your hands (hand washing, sterilizing, wearing gloves...).

نظّف يديك (غسل اليدين، التعقيم، ارتداء القفازات...).

- Ask about any pain (site, severity...).

اسأل عن أي ألم (موضعه، شدته...).

Use Your Eyes and Ears

استخدم عينيك وأذنيك

- First of all, take a good look at the patient and the surroundings: patient is bed-ridden, comfortable, any drugs on the table, any monitors or machines (e.g. nebulizer), patient position in bed, use of oxygen, use of life support....
أولاً، انظر جيداً إلى المريض والمحيط: هل المريض طريح الفراش، مرتاح، أي أدوية على الطاولة، أي أجهزة مراقبة أو آلات (مثل جهاز الرذاذ)، وضع المريض في السرير، استخدام الأكسجين، استخدام دعم الحياة....
- Take a quick look at the patient: age, gender, facies, any obvious abnormality (e.g. limb defect, injury), eye contact, able to talk or not (GCS), level of consciousness, any obvious sounds (e.g. wheeze, cough...), able to walk or not, able to move, etc.
ألقي نظرة سريعة على المريض: العمر، الجنس، الوجه (القسمات)، أي شذوذ واضح (مثل عيب في طرف، إصابة)، التواصل البصري، القدرة على الكلام أم لا (مقياس غلاسكو GCS)، مستوى الوعي، أي أصوات واضحة (مثل الصفير، السعال...)، القدرة على المشي أم لا، القدرة على الحركة، إلخ.

Sequence of Examination

تسلسل الفحص

- Usually starts from the hand, up to the pulse, BP, face... then down to the neck, chest, abdomen, lower limb.
يبدأ عادةً من اليد ثم النبض وضغط الدم والوجه... ثم إلى الأسفل نحو الرقبة والصدر والبطن والطرف السفلي.
- Other sequence: from the face going down to the limbs.
تسلسل آخر: من الوجه نزولاً إلى الأطراف.
- Either talk through the examination... or examine silently then summarize your findings at the end.
إما أن تتحدث أثناء الفحص... أو تفحص بصمت ثم تلخص ملاحظاتك في النهاية.

2. VITAL SIGNS AND THE SIX FIXED GENERAL SIGNS | العلامات الحيوية والعلامات العامة الثابتة الست

Components of General Examination

مكونات الفحص العام

- Vital signs: temperature, pulse, BP, respiratory rate.

العلامات الحيوية: الحرارة، النبض، ضغط الدم، معدل التنفس.

- SpO2.

إشباع الأكسجين (SpO2).

6 fixed general signs (العلامات العامة الثابتة الست)

- Pallor

الشحوب

- Jaundice

اليرقان

- Cyanosis

الزرقة

- Edema

الوذمة

- Clubbing

تضخم الأصابع (الأصابع الطويلة)

- Lymphadenopathy

اعتلال العقد اللمفية

Pallor

الشحوب

- Definition: pale color of the skin, mainly the face.

التعريف: لون الجلد الشاحب، خاصة الوجه.

- Pallor is seen in: palm creases, mucous membrane of the mouth, conjunctiva.

يُرى الشحوب في: ثنايا الراحة، مخاطية الفم، الملتحمة.

- Causes: anemia, fear, severe pain....

الأسباب: فقر الدم، الخوف، الألم الشديد....

(Figures: pale conjunctiva; pallor of the palm creases compared with a normal hand; pale palms.)

(الأشكال: ملتحمة شاحبة؛ شحوب ثنايا الراحة مقارنة بيد طبيعية؛ راحتان شاحبتان.)

Jaundice

اليرقان

- Yellowish discoloration of the skin and mucous membrane.

تلون أصفر للجلد والأغشية المخاطية.

- Occurs when TSB exceeds the threshold for age.

يحدث عندما يتجاوز البيليروبين المصلي الكلي (TSB) العتبة بالنسبة للعمر.

- Jaundice is seen in: sclera, skin, under the tongue.

يُرى اليرقان في: الصلبة والجلد وتحت اللسان.

(Figures: scleral icterus; yellow skin of the face and hands.)

(الأشكال: يرقان الصلبة؛ اصفرار جلد الوجه واليدين.)

Cyanosis

الزرقة

- Bluish discoloration in the skin and mucous membrane resulting from an increase in desaturated Hb in the blood of more than 4–5 g/dl.
تلون مزرق في الجلد والأغشية المخاطية ناتج عن زيادة الهيموغلوبين المنزوع الإشباع في الدم عن 4–5 غ/دل.
- 2 types: central (real cyanosis), seen mainly in the tongue; peripheral (acrocyanosis), seen in the fingers, mainly due to cold.
نوعان: مركزية (زرقة حقيقية) تُرى أساساً في اللسان؛ ومحيطية (زرقة الأطراف) تُرى في الأصابع، وسببها خصوصاً البرد.

(Figures: cyanosis of the fingers and palms; central cyanosis of the tongue and lips.)

(الأشكال: زرقة الأصابع والراحتين؛ زرقة مركزية في اللسان والشففتين.)

Edema

الوذمة

- Types: generalized and localized.
الأنواع: عامة وموضعية.
- Localized: a local cause like a peripheral lesion.
الموضعية: سبب موضعي مثل آفة محيطية.
- Generalized: causes: hepatic, cardiac, renal, intestinal and nutritional.
العامة: الأسباب: كبدية وقلبية وكلوية ومعدوية وغذائية.
- Edema definition: increase in the amount of fluid in body tissues, mainly the extracellular (EC) compartment.
تعريف الوذمة: زيادة كمية السائل في أنسجة الجسم، خاصة في الحيز خارج الخلوي (EC).

(Figures: swelling of the legs and ankles; pitting of the ankle.)

(الأشكال: تورم الساقين والكاحلين؛ انخماص الكاحل (الخفرة).)

Grade	Pitting	الانخماص
الدرجة		
Grade 1	0–2 mm indentation; rebounds immediately	انخماص 0–2 ملم؛ يرتد فوراً
الدرجة 1		
Grade 2	3–4 mm indentation; rebounds in < 15 seconds	انخماص 3–4 ملم؛ يرتد في أقل من 15 ثانية
الدرجة 2		
Grade 3	5–6 mm indentation; up to 30 seconds to rebound	انخماص 5–6 ملم؛ حتى 30 ثانية ليرتد
الدرجة 3		
Grade 4	8 mm indentation; > 20 seconds to rebound	انخماص 8 ملم؛ أكثر من 20 ثانية ليرتد
الدرجة 4		

Clubbing

تصبّع الأصابع

- Definition: deformity of the nail beds, resulting from cardiac, pulmonary, hepatic and GIT causes.
التعريف: تشوه في أسرة الأظافر ناتج عن أسباب قلبية ورئوية وكبدية وهضمية.
- Normal finger: the angle is 160° ; clubbed finger: the angle is $> 180^\circ$.
الإصبع الطبيعي: الزاوية 160° ؛ الإصبع المتصبّع: الزاوية $> 180^\circ$.

Stage المرحلة	Description الوصف
Stage 1 المرحلة 1	Normal appearance and angle but increased fluctuancy of the nail bed مظهر وزاوية طبيعيان لكن زيادة تموج سرير الظفر
Stage 2 المرحلة 2	Loss of the angle between nail and nail bed فقدان الزاوية بين الظفر وسرير الظفر
Stage 3 المرحلة 3	Increased curvature of the nail زيادة تقوُّس الظفر
Stage 4 المرحلة 4	Expansion of the terminal phalanx – drumstick appearance توسع السلامى الانتهائية – مظهر عصا الطبل

(Figures: normal vs distorted angle of the nail bed; the "window" test – a window (gap) is seen between the nails of two opposed normal fingers and is lost in clubbed fingers.)

(الأشكال: زاوية سرير الظفر الطبيعية مقابل المشوّهة؛ اختبار "النافذة" – تُرى نافذة (فراغ) بين ظفري إصبعين طبيعيين متقابلين وتختفي في الأصابع المتصبّعة.)

Lymphadenopathy

اعتلال العقد اللمفية

- Examining lymph node groups in the body.

فحص مجموعات العقد اللمفية في الجسم.

Figure labels (head and neck lymph nodes): preauricular, parotid, retropharyngeal (tonsillar), submandibular, submental, anterior cervical, supraclavicular nodes (palpable when there is disease), occipital, postauricular, posterior cervical; second figure: facial, jugulodigastric (tonsillar), posterior auricular, external jugular, anterior deep and superficial cervical, posterior superficial cervical, posterior cervical spinal nerve chain, supraclavicular. A further photograph shows a swollen neck lymph node.

تسميات الشكل (عقد الرأس والرقبة): أمام الأذن، النكفية، خلف البلعوم (اللوزية)، تحت الفك، تحت الذقن، العنقية الأمامية، العقد فوق الترقوة (تُجس عند وجود مرض)، القذالية، خلف الأذن، العنقية الخلفية؛ الشكل الثاني: الوجهية، الوداجية الهضمية (اللوزية)، الخلفية للأذن، الوداجية الخارجية، العنقية الأمامية العميقة والسطحية، العنقية الخلفية السطحية، سلسلة العصب الشوكي العنقية الخلفية، فوق الترقوة. وتُظهر صورة أخرى عقدة لمفية متورمة في الرقبة.